

Análisis de la situación de la vacunación materna para Virus Sincial Respiratorio

Unidad Centinela -IRAG e IRAG extendida. Hospital Regional de Río Gallegos

1. Introducción

En Argentina incorporó en marzo de 2024, la vacunación al calendario nacional para el Virus Sincial Respiratorio, lo que subraya la importancia de realizar estudios de carga de enfermedad, efectividad e impacto de la vacunación para documentar la reducción de hospitalizaciones en recién nacidos y lactantes.

Considerando la importancia de contar con establecimientos de salud que aporten información de calidad, particularmente para los mencionados estudios de la vacuna de VSR, y los antecedentes y desafíos que se han presentado en la implementación de las distintas estrategias de vigilancia.

La estrategia de Unidad Centinela de Infección Respiratoria Aguda Grave (UC-IRAG) permite consolidar la información generada para contribuir a la toma de decisiones sanitarias y a la organización de la respuesta hospitalarias, particularmente las internaciones.

En la provincia de Santa Cruz, la estrategia UC-IRAG comenzó a implementarse en la semana epidemiológica 18 de 2024 en el Hospital Regional Río Gallegos, establecimiento de referencia provincial por ser de mayor densidad poblacional que refleja una información orientativa de la evolución de los casos.

El presente informe describe los casos de IRAG e IRAG extendida en niños menores de 11 meses registrados por la Unidad Centinela, considerando su distribución temporal y etaria, la detección de Virus Sincial Respiratorio y el estado vacunal materno considerando los períodos establecidos en la campaña de vacunación para VSR.

2. Objetivo general

Describir el comportamiento epidemiológico, etiológico y vacunación materna de los casos de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) e IRAG extendidas (IRAGE) notificados por la Unidad Centinela del Hospital Regional Río Gallegos entre la semana epidemiológica 18 de 2024 y la semana epidemiológica 32 de 2026, con el propósito de aportar información oportuna para la vigilancia epidemiológica y el análisis del impacto sobre el sistema de salud.

3. Ejes de análisis

El presente informe analiza el comportamiento temporal de los casos de IRAG e IRAG extendida, la circulación de Virus Sincial Respiratorio, la distribución según grupos etarios, antecedentes materno de vacunación según semana de gestación.

4. Definiciones operativas y criterios de inclusión

La clasificación de los casos se realizó de acuerdo con las definiciones establecidas para la estrategia de vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG).

IRAG

Se considera caso de IRAG a todo paciente, de cualquier edad, con infección respiratoria aguda que presenta:

- fiebre referida o constatada mayor o igual a 38 °C;
- tos;
- inicio del cuadro en los 10 días previos;
- requerimiento de internación por criterio clínico.

IRAG extendida

Se considera caso de IRAG extendida a pacientes menores de 2 años o personas de 60 años o más que presentan:

- infección respiratoria definida por tos o dificultad respiratoria;
- inicio del cuadro en los 10 días previos;
- requerimiento de internación por criterio clínico.

En lactantes menores de 6 meses, también se consideran criterios clínicos relevantes la presencia de apnea o sepsis, entendida como fiebre o hipotermia, shock y cuadro grave sin causa aparente.

Estas definiciones permiten diferenciar los casos captados por la definición clásica de IRAG de aquellos incorporados mediante la estrategia ampliada de IRAG extendida, lo cual resulta fundamental para interpretar adecuadamente la magnitud, severidad e impacto de los eventos analizados.

Para mayor detalle sobre las definiciones operativas, criterios de inclusión, circuito de notificación e indicadores de la estrategia UC-IRAG, consultar la guía operativa nacional vigente:

[Guía Operativa UC-IRAG – Ministerio de Salud de la Nación](#)

5. Nota metodológica

El presente informe integra información proveniente de la notificación nominal de casos registradas en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud —SNVS 2.0—.

El período evaluado comprende desde la semana epidemiológica 18 de 2024 hasta la semana epidemiológica 32 de 2026. El procesamiento de los datos, se realizó mediante el software R, incluyendo procedimientos de limpieza, depuración, clasificación y análisis descriptivo, con el propósito de garantizar trazabilidad, consistencia y reproducibilidad en la construcción de los indicadores.

Para la construcción de los indicadores se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión establecidos por la vigilancia específica de Virus Sincical Respiratorio. Los resultados deben interpretarse como información de vigilancia centinela hospitalaria, útil para monitorear tendencias, severidad e impacto, pero no como tasas poblacionales provinciales.

6. Situación epidemiológica

Entre la semana epidemiológica 18 de 2024 y la semana epidemiológica 32 de 2026, se registraron un total de 106 internaciones notificadas en el marco de la estrategia UC-IRAG-HRRG.

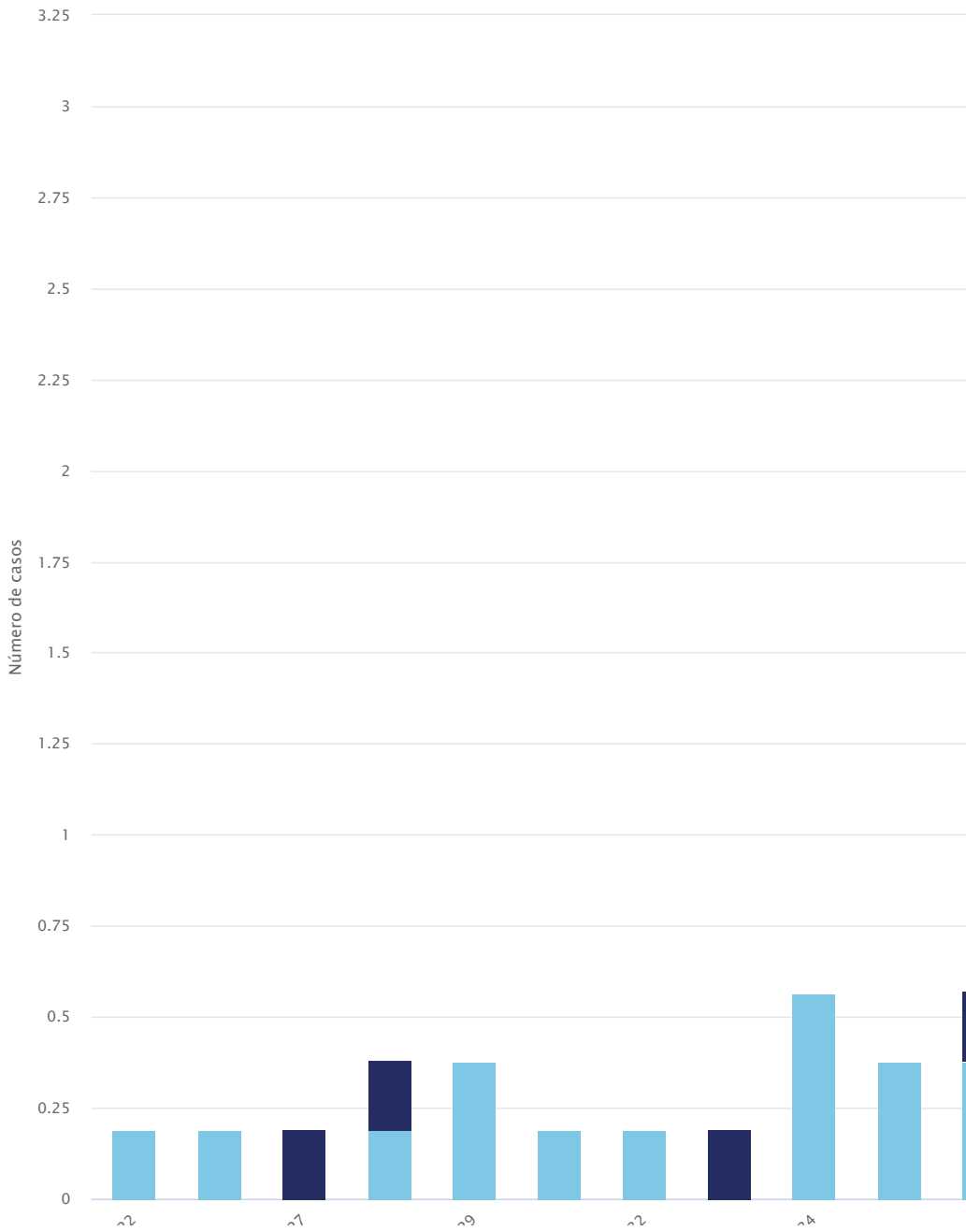
6.1 Distribución temporal según grupo etario

A continuación, se presenta la distribución temporal de los casos notificados en menores de 11 meses. Para mantener coherencia con los criterios operativos de la vigilancia centinela y facilitar la interpretación epidemiológica, el análisis se organiza en tres grupos poblacionales: de 0 a 2 meses, de 3 a 5 meses y de 6 a 11 meses.

6.1.1 De 0 de 2 meses

Gráfico 1. Distribución semanal de casos de IRAG e IRAG extendida de 0 a 2 meses . Unidad Centinela de IRAG, Hospital Regional Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.

Casos de IRA

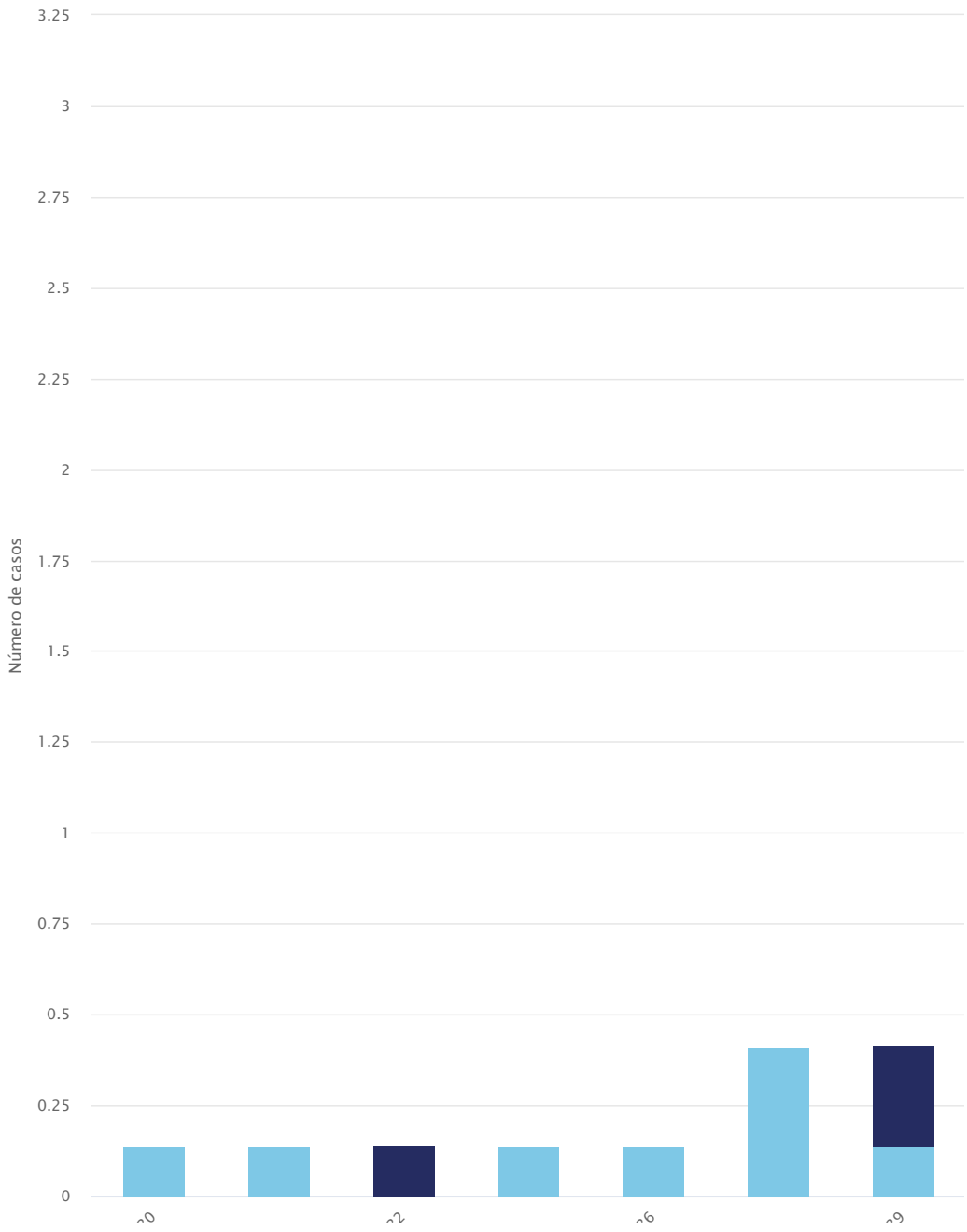


Fuente: Elaboración propia con base en datos del SNVS 2.0

6.1.2 De 3 a 5 meses

Gráfico 2. Distribución semanal de casos de IRAG e IRAG extendida de 3 a 5 meses. Unidad Centinela de IRAG, Hospital Regional Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.

Casos de IRA

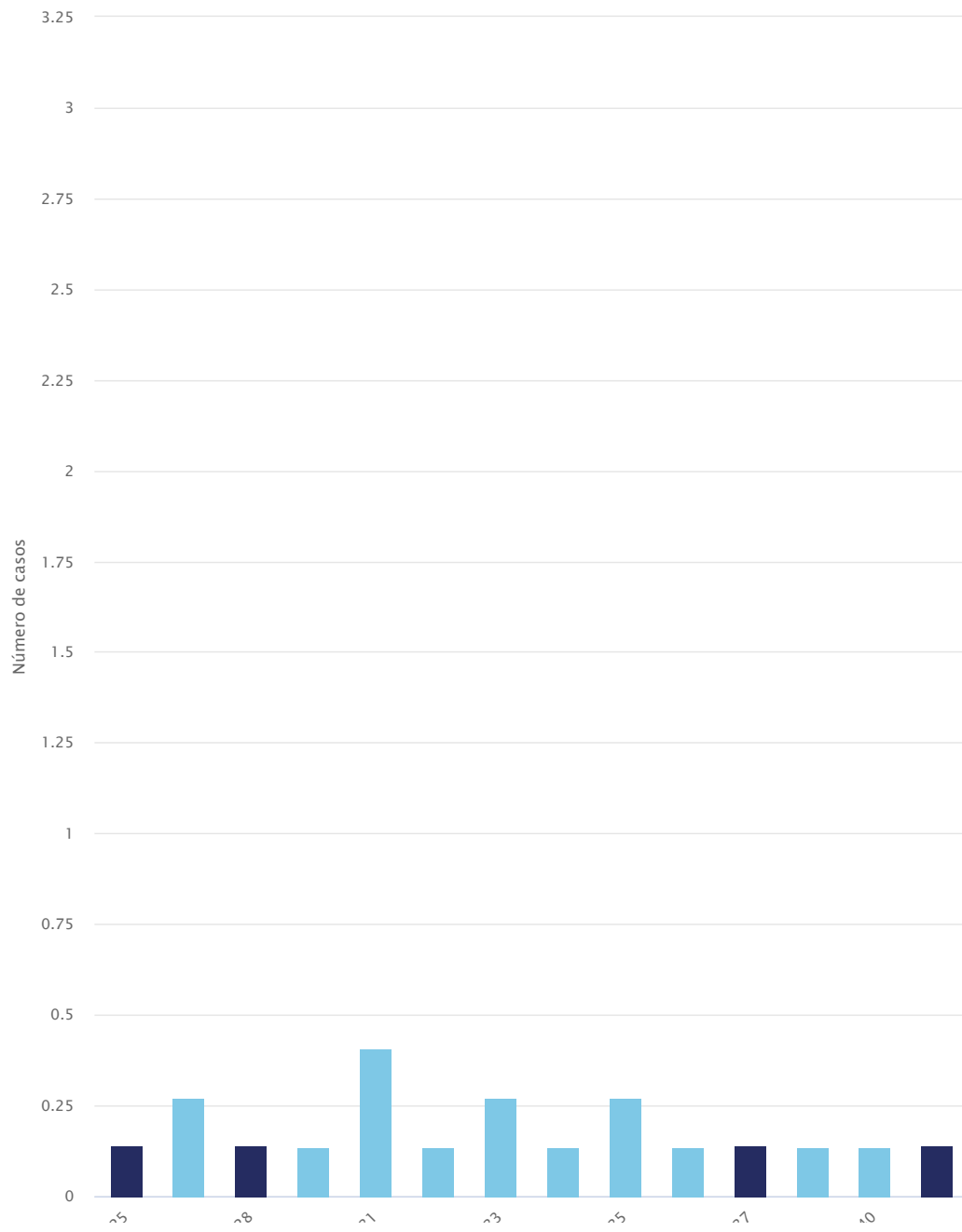


Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNVS 2.0

6.1.3 De 6 a 11 meses

Gráfico 3. Distribución semanal de casos de IRAG e IRAG extendida de 6 a 11 meses. Unidad Centinela de IRAG, Hospital Regional Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.

Casos de IRA



Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNVS 2.0

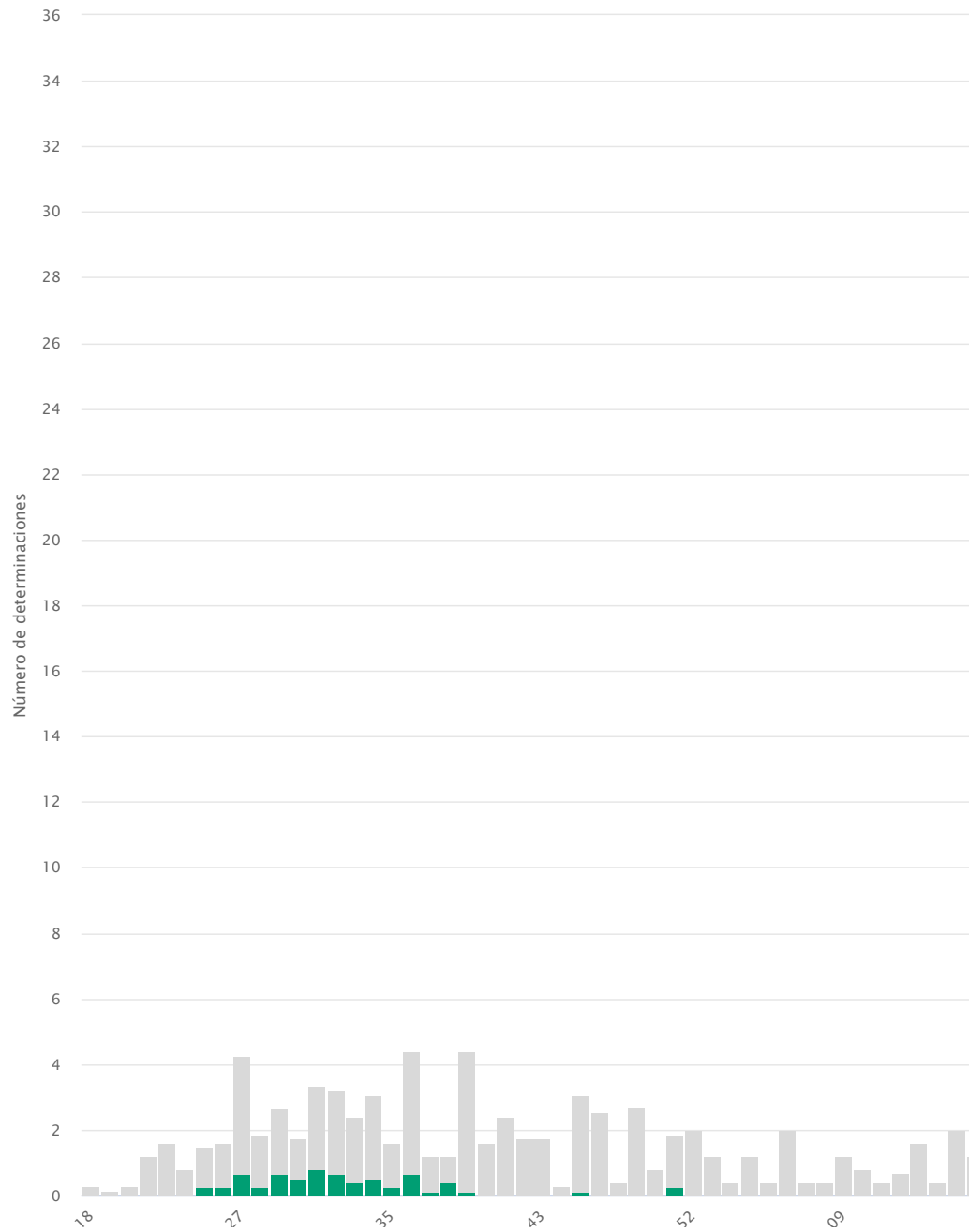
6.2. Determinaciones para Virus Sincicial Respiratorio en menores de 11 meses

En esta sección se presenta la distribución temporal de las determinaciones realizadas para Virus Sincicial Respiratorio en vigilancia, así como las determinaciones con resultado negativo.

Gráfico 4. Determinaciones para Virus Sincicial Respiratorio según semana epidemiológica y año. Resultados positivos VSR y determinaciones negativas. Unidad Centinela de IRAG, Hospital Regional Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.

Determinación para Virus S

Resultados positivos para VSR



Estado de vacunación materna para VSR por año

Menores de 11 meses internados IRAG - HRRG

semana_gestacion	n_2024	n_2025	n_2026
32	2	3	0
34	0	1	0
35	2	1	0
36	3	5	1
Otra semana	0	0	1
Vacunada - semana desconocida	0	2	2
No vacunada	46	24	6
Sin dato	2	3	2
Total de casos de IRAG/IRAGe en < 11 meses	55	39	12

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del SNVS 2.0 y drive

6.3 Porcentaje de vacunación materna en menores de 11 meses

En pacientes menores de 11 meses, el antecedente de vacunación materna para Virus Sincial Respiratorio constituye una variable relevante para interpretar el riesgo de infección respiratoria grave. Durante el período de estudio, se evaluó la vacunación materna con respecto a los casos presentados.

Factores a tener en cuenta en el presente análisis: período establecido de estrategia de vacunación para VSR, posible desconocimiento de la vacuna materna en el ámbito privado y/o embarazos no controlados.

Tabla 1. Vacunación VSR materna en pacientes menores de 11 meses. Unidad Centinela de IRAG, Hospital Regional Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNVS 2.0

Año 2026 hasta semana 32